健護財報及選後展望



分析師 / 林珍安
研究範疇 / 健護

市場投資展望

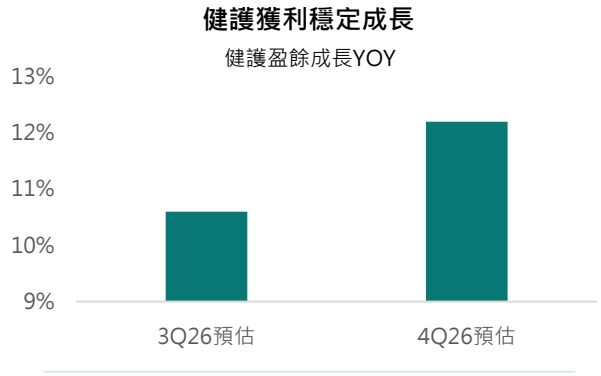
資產	4Q26看法	投資展望
健護	正向	民主黨贏得兩院對降低處方藥價及PBM監管持續，但法案協商的可能性有利投保人數止跌回升。就財報及展望表現，仍優先看好製藥。

熱門議題 / 投資關鍵

民主黨贏得兩院對降低處方藥價及PBM監管持續，但法案協商的可能性將有利投保人數止跌回升。就財報及展望表現，仍優先看好製藥。

pg1

本月關鍵圖表



資料來源：LSEG，2026/11/6，中國信託商業銀行整理，2026/11/6

重點摘要

- 受惠減重、腫瘤及免疫新藥銷售放量，加上臨床管線與策略併購補充，製藥業展現穩健動能，為健護首選次產業。

《製藥多受惠新藥銷售為成長動力》

適逢財報季及美國民主黨贏得兩院。就藥業影響，降低處方藥價為兩黨共識，現已有IRA藥價談判及最惠國藥價政策進行中，預期廠商有多元化產品線可應對。在財報方面，標普五百健護財報公布迄今，營收及獲利優於預期比重超過九成，在藥業，主要受惠抗肥胖、腫瘤、免疫及神經科學新藥銷售增加，在禮來成長動能來自國際市場及進入美國Medicare市場，美國降價取得銷量成長，口服Foundayo今年成長不如預期，明年及之後因全球陸續上市，仍將穩定增加，後續雖有其他競爭者可能加入減重市場，但因減重藥朝長期維持而非短期使用、適應症擴及長期器官保護使整體市場規模仍高。嬌生(JNJ)3Q26展現多線骨髓瘤藥物銷售呈現雙位數成

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。

重點摘要

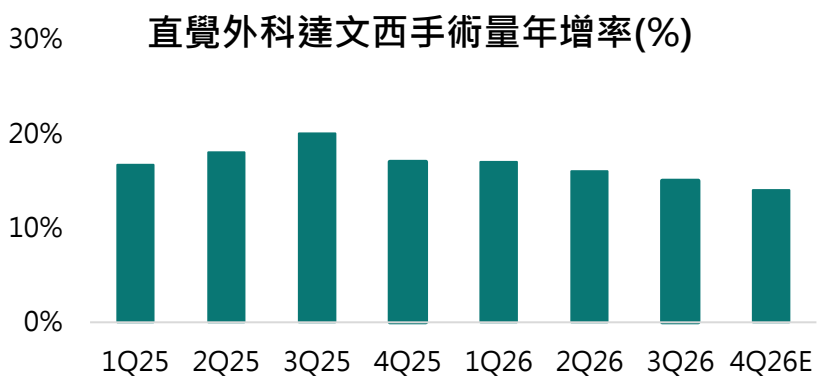
- 3Q26醫材動能分化，整體成長動能仍弱，預期明年不利因素緩解及新產品陸續推出，將緩步走出低谷。

長，Tremfya切入發炎性腸道疾病領域呈現大幅成長，新藥Icotyde(銀屑病口服胜肽)、Inlexzo(膀胱癌)放量將成為新成長支柱。JNJ與艾伯維(ABBV)在免疫藥品領域的競爭，但IL-23(Tremfya、Skyrizi)、JAK抑制劑(Rinvoq)都是先進療法，也在替代傳統用藥市場。除此之外，新藥等待FDA批准或多種臨床實驗產品線，加上併購補充未來成長差異化產品線，製藥仍呈現穩定成長，為健護產業看好次產業。

《醫療器材成長動能分化，預期明年漸出低谷》

美國兩黨對醫療器材的著墨度較低，預期不受國會結構改變影響。就財報部分，3Q26醫材動能分化，嬌生(JNJ)醫療科技部門營收成長僅2.5%，主要受惠心血管類成長4.1%，但被受中國帶量採購(VBP)、中東衝突干擾標案時程的一般外科拖累；亞培(ABT)受左心耳封堵器觀望等待新品推出及血糖監測器國際降價影響，下調全年營收增速至約6%，兩家公司同樣期待明年不利因素緩解，加上多款新產品陸續推出，預期將緩步走出低谷。微創機器人手術於3Q26全球手術量年增率為15%，預期4Q26全球手術量年增率約14.5%，3Q26美國達文西手術成長放緩至僅10%，公司表示主因基期影響，預期未來因擴大使用計畫降價3~5%取得量的成長，門診手術使用量增及新的適應症，將使美國市場呈現穩定或改善。

下圖/機器人手術量4Q26放緩



資料來源：ISRG，2026/11/1，中國信託商業銀行整理，2026/11/6

《管理式醫療機會與風險兼具，醫療成本改善》

民主黨贏得參眾兩院，對2025年底已到期的平價醫療法案(ACA)增強型保費補貼，受淨保費上升，已經有超過200萬人放棄投保，及受大而美法案被削減的醫療補助(Medicaid)在2025~2034年超過

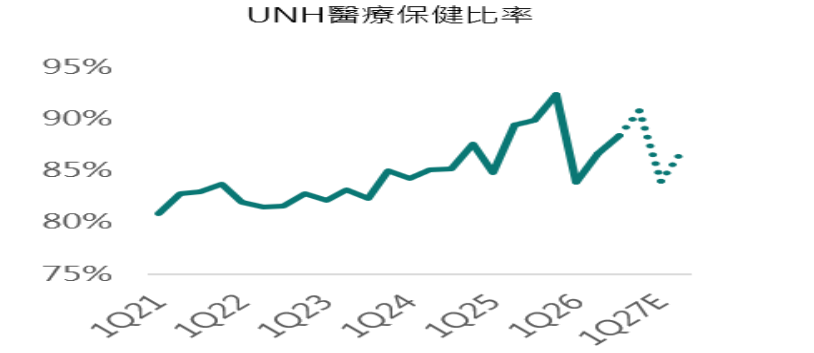
【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。

重點摘要

- 民主黨贏得國會兩院，增加可以協商ACA增強型補貼部分恢復、醫療補助刪減延後的機會，但對藥物服務管理機構的監管持續。
- 管理式醫療機構維持利潤優先於規模、重定價改善醫療成本，雖4Q26醫療成本季節性續升，但預期2027年改善，維持兩位數獲利成長。

9000億美元。現ACA進行增強型補貼的恢復提案還在進行中，須總統立法才能恢復，可以是談判交換條件的一部分，醫療補助的刪減是已立法，分階段生效，無法被推翻，只能延後刪減，其中對工作的要求將於年底生效早於新國會就任，12/11臨時撥款法案談判是可以納入談判作為局部修正的時間點。若醫療補助刪減延後，將有利於醫院，若ACA補貼部分恢復將有利於ACA型管理式醫療業者的投保人數止跌回升。兩黨均支持對藥物管理福利機構(PBM)的監管，已有法案讓Part D藥價與PBM的報酬脫鉤，回扣必須全數轉交給計畫方，2028年生效，現業者多將Part D回扣與價差收入轉為固定費用應對，對激進者業務分拆的主張則可能以聽證、調查形式出現而非馬上立法。但在州層級，阿肯色州禁止PBM擁有藥局的法律在州政府上訴中，CVS已決定1H28分拆藥局成兩家獨立公司應對。就財報部分，UNH 3Q26財報仍維持業者利潤優先於規模與核保紀律，合約重定價與刪除不賺錢合約，運用AI改善營運效率、提升服務品質，在藥物福利管理主動讓利降低政策風險。聯合醫療保險(UHC)因保費重定價與醫療成本管控抵銷投保人數萎縮，Optum Health退出虧損市場，聚焦高回報價值導向醫療運營紀律，使此兩業務部門利潤率提升優於預期。商業保險醫療成本趨勢依然高，但已趨於穩定，醫療優勢計畫(MA)利潤率已接近2%-4%目標區間上限，公司自評2027/2028年接近75%會員可望維持在4星以上方案。醫療補助仍虧損，將透過州費率調整將緩步走出低谷。4Q26醫療成本趨勢雖因季節性因素走升，為今年獲利低點，但明年多項利潤率改善可期，維持兩位數獲利成長。

下圖/4Q26醫療成本季節性走升，預期明年改善



資料來源：UNH、彭博，2026/10/16，中國信託商業銀行整理，2026/9/30

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。